蜂窩織炎様皮膚病変を契機に診断された播種性クリプトコッカス症

◎加藤 万里有[1)]、東本 祐紀[2)]、松井 建二郎[1)]、下坂 寿希[1)]、星 雅人[2)]
藤田医科大学病院[1)]、藤田医科大学[2)]

【はじめに】クリプトコッカス症は、肺や中枢神経病変を主体とすることが多いが、皮膚病変を契機に診断されることがある。免疫不全患者では、菌血症や髄液への播種を伴う場合があり、早期診断と治療が重要である。今回、蜂窩織炎様皮膚病変を契機に診断された播種性クリプトコッカス症の 1 例を経験したため報告する。

【症例】80 代女性。強皮症のためステロイドを内服中。2 週間前から右下腿の発赤と疼痛を自覚していた。車のドアに右下腿を挟んだことを契機に、予約外で皮膚科を受診した。同部位に挫創、血腫を認めたが、血液培養採取後に一時帰宅となった。翌日の再診時に発熱と CRP の上昇を認めたため蜂窩織炎が疑われ入院となり、セファゾリンの投与が開始された。

【微生物学的検査・治療経過】血液培養 2 セット中、好気ボトル 2 本が採取 60 時間後に陽性となった。陽性ボトルの Gram 染色で酵母様真菌を認め、クロムアガーカンジダ寒天培地（日本 BD）に分離培養した。培養翌日は微小コロニー、その翌日に淡桃色を帯びた白色コロニーが形成され、MALDI バイオタイパー（version 2023, Bruker） にて *Cryptococcus neoformans* と同定された。Gram 染色結果から、ミカファンギンが投与されたが、菌名報告後にアムホテリシン B およびフルシトシンに変更された。さらに挫創部の皮膚生検、髄液検査が実施され、両検体からも同菌が検出された。また、治療開始 1 週間後に採取された血液培養で陰性が確認された。

【考察】本症例は外傷後の蜂窩織炎として入院したが、血液培養で C. *neoformans* を同定したことを契機に皮膚生検と髄液検査が追加され、播種性クリプトコッカス症の診断に至った。本菌は初期治療で想定されにくく、菌種同定後に抗真菌薬の変更を要するために、迅速な同定が治療方針決定に重要である。免疫抑制患者で蜂窩織炎様皮膚病変をみとめた場合、血培培養の積極的な提出が望まれる。

【結語】免疫抑制患者の蜂窩織炎様病変では、細菌感染症だけでなく *C. neoformans* も鑑別に挙げ、迅速な同定と播種性病変の検索が重要である。　連絡先：0562-93-2304